

Redazione di una relazione professionale sulla base dell'analisi di documenti, tabelle, dati.

Obiettivi della prova

- 1.Utilizzare le forme di comunicazione più idonee rispetto al contesto operativo*
- 2.Pianificare le azioni da realizzare secondo una corretta sequenza logico-operativa*
- 3.Riconoscere i bisogni delle persone o dei gruppi e le possibili azioni per il loro soddisfacimento*
- 4.Individuare e presentare servizi e prestazioni a sostegno delle persone*
- 5.Individuare le figure professionali e operative e i loro ruoli all'interno dei gruppi di lavoro e delle reti formali e informali*
- 6.Utilizzare in modo appropriato documenti, dati, tabelle, grafici, informazioni nella redazione degli elaborati*

Il candidato/la candidata sulla base dei documenti (tabelle, dati statistici....) allegati alla prova, in qualità di operatore dei servizi sociali, elabori una relazione destinata a..... avente lo scopo di organizzare informazioni attendibili e funzionali alla fruizione dei servizi inerenti la situazione problematica descritta/rappresentata nei documenti.

Nell'elaborazione del documento il candidato/la candidata individui:

1. i/le destinatari/destinatarie della relazione

Per destinatari della relazione si intende colui o coloro ai quali vi rivolgete per informare/sensibilizzare l'attenzione circa un determinato argomento/fenomeno meritevole di intervento. Per esempio potrebbe essere la conferenza dei servizi del PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona, istituiti ai sensi della Legge Regionale n. 23/2005); oppure, essendo un operatore presso i servizi sociali si proporrà la relazione all'assessore ai Servizi Sociali evidenziando delle criticità; ancora, facendo parte attiva di un'associazione del terzo settore, la vostra relazione sarà indirizzata e/o presentata all'assessorato regionale per la Sanità e i Servizi Sociali al fine di informare della situazione dei vostri associati e proporre interventi a far leva su fondi regionali; e così via...

2. la situazione problematica che emerge dall'analisi dei dati.

In questo punto della relazione è opportuno fornire uno sguardo d'insieme circa la problematica, in modo stringente, preciso e con decisione. Sarà necessario fare una scaletta di priorità da evidenziare, partire dal quadro generale. Nel caso dell'invecchiamento della popolazione, per esempio, si può aprire così: "Secondo i dati che emergono dalle ricerche ISTAT, il trend demografico italiano è caratterizzato da un invecchiamento della popolazione, conseguentemente da quote sempre più elevate di anziani non autosufficienti e bisognosi di assistenza. La previsione futura porta a prendere in considerazione e con urgenza un ripensamento delle politiche pubbliche in questo settore, nonché le modalità di progettazione e di intervento a favore degli anziani parzialmente e totalmente non autosufficienti." Via via dovrà essere descritto il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione più nello specifico, per esempio individuando nello le fasce di età più colpite da cronicità e demenza,

da limitazione funzionale e in quali aree urge intervenire, le differenze fra maschi e femmine, le differenze regionali tra Nord e Sud d'Italia e se possiedono dati sempre più rifiniti per andare a rafforzare la tesi che si sostiene nella *relazione professionale* che si prepara e che legittima l'intervento che si propone. Obiettivo è dar voce a soggetti bisognosi e/o con patologie che necessitano di cure e interventi socio-sanitari.

3. gli interventi idonei ad affrontare il problema anche con la collaborazione di reti formali ed informali.

Qui sarà opportuno, a fronte del quadro che avrete tracciato nel punto precedente, individuare gli interventi ritenuti più idonei. Sempre nel caso della popolazione anziana, e più in generale riguardo all'invecchiamento della popolazione, potranno essere proposti interventi e servizi ritenuti adeguati a offrire risposte concrete: sia a livello di interventi e servizi ma anche di cambiamento di paradigma (il paradigma è un modo di pensare la realtà, in genere corrisponde al “come si è sempre fatto”); oppure ancora sarà possibile proporre delle politiche sociali innovative per questa specifica popolazione. Si potrà fare ricorso a tutte le tipologie di servizi di welfare per la non autosufficienza e per gli anziani in generale, elaborando una proposta originale che preveda l'integrazione del sociale con il sanitario, non disdegnando anche progetti e ipotesi come: gruppi appartamento per anziani e anziane o attività di socializzazione e scambio interculturale. Sarà possibile anche immaginare degli interventi esistenti e/o prevedere la modifica, ad esempio la graduazione dell'Indennità di Accompagnamento erogata dall'INPS per persone non autosufficienti e invalide al 100% in base all'ISEE (cosa che adesso non avviene in quanto misura universalistica), oppure prevedere che possa essere erogata una quota maggiore a coloro che usano quei soldi in servizi socio-sanitari (ciò non accade perché è una prestazione esclusivamente economica); Ancora potrebbe essere anche proposto un metodo di autofinanziamento dei servizi come accade del cosiddetto welfare integrativo e/o assicurativo in cui le assicurazioni garantiscono servizi, cure e prestazioni a fronte del pagamento annuale di una quota (tale quota potrebbe essere calcolata in percentuale sugli stipendi dei singoli che decidono di assicurarsi contro il rischio futuro di non autosufficienza). E così via...

4. la/le modalità di accesso ai servizi ipotizzati

Sarà ora necessario individuare le modalità di accesso ai servizi ipotizzati. Ovvero chi e come potrà usufruirne. Così come decidere se si tratterà di un servizio totalmente gratuito o a pagamento, o a metà tra i due. In genere i servizi sociosanitari e socioassistenziali pubblici prevedono sempre una compartecipazione economica dell'utente che, spesso, è stabilita in base all'ISEE – cioè la prova dei mezzi e delle risorse che un nucleo familiare possiede per far fronte alle necessità specifiche. Nel caso il servizio fosse a completamente a pagamento dovrà naturalmente essere specificato e stabilire – ma lo stesso vale anche fosse a compartecipazione – la tariffa oraria o prestazione o al giorno. Ancora sarà necessario prevedere le caratteristiche dei destinatari dei servizi: ad esempio definire che all'assistenza e animazione domiciliare potranno accedere solo le persone parzialmente non autosufficienti con non meno di 75 anni. Mentre all'assistenza domiciliare integrata (sociosanitaria) potranno accedere le persone totalmente non autosufficienti, al di là dell'età, prevedendo una compartecipazione dell'utente in base all'ISEE (secondo il criterio più risorse hai più partecipi). Un altro esempio: per i gruppi appartamento potranno fare domanda coloro che sono autosufficienti e che hanno superato i 70 anni di età: in questo caso si potrebbe prevedere una graduatoria in base alla numerosità del nucleo di appartenenza in modo tale che coloro che sono sprovvisti di rete informale e dunque familiare siano avvantaggiati nell'accesso al servizio. Sempre in questo caso, altro criterio di precedenza potrebbe essere il genere, per esempio, per diverse motivazioni che potrebbero essere sostenute dai dati di cronicità e salute. E così via...

5. le eventuali carenze a livello dei servizi di riferimento

Individuare la carenza dei servizi proposti o la necessità di rafforzare l'offerta presente sul territorio, ritenuta da voi non sufficiente a soddisfare i bisogni. È vero che i servizi nel territorio esistono, ma è anche vero che spesso sono saturi di domande, oppure non capillarmente diffusi su tutto il territorio, oppure quelli a pagamento vengono preferiti perché più facilmente accessibili e migliori in termini di standard di qualità, oppure ancora perché non propositivi di un modello di miglioramento della vita delle persone ai quali si riferiscono o poco sostenibili.

6. le possibili modalità di diffusione delle informazioni utili a favorire l'accesso ai servizi

In questa parte della *relazione professionale* ci si dovrà concentrare sull'individuazione dei canali di comunicazione che si riterranno più idonei per raggiungere i destinatari dei vostri interventi. Tenendo presente che il welfare pubblico prevede il “segretariato sociale” come servizio preferenziale e deputato a queste attività di informazione al cittadino circa i servizi presenti sul territorio ma anche sui criteri di accesso ecc., sarà opportuno prevedere forme innovative ed efficaci di comunicazione per far conoscere i servizi e favorire l'accesso alle persone potenzialmente interessate: dalle forme tradizionali (cartellonistica e volantinaggio) a quelle altrettanto tradizionali ma broadcasting (tv, radio), a quelle più innovative e moderne (internet, siti, social network, ecc.).